ICS ***

CCS ***

团 体 标 准

T/CACM XXX—2019

中医药整体证据研究的标准化操作规程

Standard operating procedures of whole-evidence method for Chinese Medicine

（稿件类型：公示稿）

（本稿完成时间：2020 年 3 月）

公示稿

201×-××-××发布　　201×-××-××实施

中 华 中 医 药 学 会发布

公示稿

ICS ***

CCS ***

团 体 标 准

T/CACM XXX—2019

中医药整体证据研究的标准化操作规程 第 1 部分:总则

Standard operating procedures of whole-evidence method for Chinese Medicine Part 1: General rules

公示稿

（稿件类型：公示稿）

（本稿完成时间：2020 年 3 月）

201×-××-××发布　　201×-××-××实施

中 华 中 医 药 学 会发布

公示稿

公示稿

公示稿

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　术语和定义 1
3　整体证据研究方法的指导原则 2
4　整体证据方法研究与应用的基本内容 2

公示稿

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

T/CACM***《中医药整体证据研究的标准化操作规程》分为三个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：古籍证据梳理的标准化操作规程

——第3部分：现代研究证据梳理的标准化操作规程

本部分为T/CACM***的第1部分。

本标准由中华中医药学会提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)。

本标准参与起草单位：中国中医科学院中医临床基础医学研究所、上海中医药大学、北京中医药大学东直门医院。

本标准主要起草人：卢传坚、薛长利、郭新峰、张林、温泽淮、刘少南、Brian May、谢雁鸣、王拥军、商洪才、杨丽虹、Meaghan Coyle、李慧、陈婧、Johanna Shergis、谢秀丽、Claire Zhang、何怡瀚、Yuan Ming DI、赖佳琪。

公示稿

引　言

循证医学对临床疗效研究证据评价与推荐的指导作用已得到了国际医学界的广泛认可。中医药临床疗效证据的循证医学证据总结亟需依托规范的技术方法和标准化操作规程。对中医药数千年来的经验进行系统整理和严格评价，实现对浩瀚文献的去粗存精、去伪存真，这是中医药继承与发扬的必由之路。针对中医药领域现代高质量随机对照试验等证据较少，古籍记载与专家经验、共识等其他证据对临床仍有重要指导作用的现状，本项目提出中医整体证据的理论，综合集成中医古籍、现代文献、名医经验、指南共识、教材专著等多来源证据形成证据体，进而制定规范中医药现代临床研究证据、专家经验与共识性证据、中医古籍证据挖掘等整体证据的一系列研究方法的标准操作规程，并涵盖实验室研究证据等支持性证据的系统收集、整理、分析和评价的过程，从而快速高质量地形成可供国际范围内应用的中医药临床循证医学证据，有利于推动中医药临床实践跟上现代循证医学的步伐，有利于解决中医临床教材循证资料缺乏，医师可借鉴最佳证据少的问题。对发展循证中医药学，巩固与提高我国在国际中医药教育、临床和科研中的地位具有重要的意义。

本标准提出中医药整体证据研究的标准化操作规程总体原则，明确了中医药整体证据的内涵及其整体证据研究的主要内容，将为中医药证据的系统研究、中医药领域的循证临床实践指南制修订、高等教育与继续教育、以及药物研发提供参考。

公示稿

公示稿

中医药整体证据研究的标准化操作规程

第 1 部分：总则

1 范围

本标准规定了中医整体证据的构成和研究涵盖的内容。

本标准适用于中医药循证临床实践指南的制修订、需要提供整体证据的行为规范指南等。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

临床研究证据 Evidence of clinical study

以人为研究对象、有特定研究目的和研究设计的临床研究，主要目的在于评价某种干预措施的临床疗效评价与安全性。

2.2

专家共识 Expert consensus

采用一种形式，通过一定的方法集合不同个体提出的多种建议或意见，并最终达成共识。

2.3

专家经验 Expert experience

某领域内的专家个人对某些科学问题的经验（常见的是对某病的诊疗经验）。

2.4

中医古籍证据 Evidence of classical Chinese medicine literature

中国古代各种医籍（主要指1912年以前）中记载的中医药诊疗经验、认识或理论。

2.5

整体证据 Whole evidence

针对某一疾病（或健康状态），系统整理的包括古籍证据、专家经验、共识性证据、临床研究证据和临床前实验室药理研究证据等多来源证据的整体，较传统的基于现代临床研究的循证证据范围更广。

公示稿

3 整体证据研究方法的指导原则

3.1 遵循科学发展规律，促进中医药诊疗经验的去粗存精、去伪存真。

3.2 符合国际临床研究、疗效评价、临床推荐的基本原则。

3.3 充分考虑中医药学科发展阶段与临床诊疗特色。

3.4 考虑疾病的国际治疗进展与中医药需求。

3.5 系统整理及严格评价不同来源、不同类型证据。

3.6 对中医药的临床疗效进行科学、客观、定量呈现。

4 整体证据方法研究与应用的基本内容

4.1 建立和完善中医药整体证据概念与方法。

4.2 中医古籍证据的检索与评价方法。

4.3 现代临床研究证据的检索与评价方法。

4.4 临床前实验室药理研究证据的检索与汇总方法。

公示稿

ICS ***

CCS ***

团 体 标 准

T/CACM XXX—2019

中医药整体证据研究的标准化操作规程
第 2 部分:古籍证据梳理的标准化操作规程

Standard operating procedures of whole-evidence method for Chinese Medicine
Part 2: Standard operating procedures of Identification and evaluation of classical literature

公示稿

（稿件类型：公示稿）

（本稿完成时间：2020 年 3 月）

201×-××-××发布　　201×-××-××实施

中 华 中 医 药 学 会发布

公示稿

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　术语和定义 1
3　确定疾病相关的古籍检索词 1
4　条文的纳入排除标准 2
5　《中华医典》第五版的检索及条文筛选 2
6　古籍数据处理 3
7　古籍数据分析 4
附录 A（规范性附录）判定为古籍重复条文的四种情况 6

公示稿

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

T/CACM***《中医药整体证据研究的标准化操作规程》分为三个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：古籍证据梳理的标准化操作规程

——第3部分：现代研究证据梳理的标准化操作规程

本部分为T/CACM***的第2部分。

本标准由中华中医药学会提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)。

本标准参与起草单位：中国中医科学院中医临床基础医学研究所、上海中医药大学、北京中医药大学东直门医院。

本标准主要起草人：卢传坚、薛长利、郭新峰、张林、温泽淮、刘少南、Brian May、谢雁鸣、王拥军、商洪才、杨丽虹、Meaghan Coyle、李慧、陈婧、Johanna Shergis、谢秀丽、Claire Zhang、何怡瀚、Yuan Ming DI、赖佳琪。

。

公示稿

引　言

古籍证据的整理与评价一直是中医循证医学的难点之一，主要原因是中医与西医认识人体与疾病的角度不同，大多数古代医案记录的是古人针对某一症状、病机、证候等的认识，而非西医学的疾病概念。本标准创新性地建立了包括中医病名、相关症状体征及病史特征在内的古今病名诊断相似性评价系统，针对西医疾病的诊断特点，制定现代疾病对应的古代病名或类证的诊断或评价要点，对《中华医典》中所载一千余本古籍中与研究疾病相关的内容进行了系统检索、梳理和评价，全面总结了疾病命名演变、病因病机认识、临床治疗规律（常用方剂、中药和针刺穴位）等内容，古籍证据的系统梳理将为现代中医临床实践提供更全面的参考，并可为临床及实验研究提供方向。

公示稿

公示稿

中医药整体证据研究的标准化操作规程

第 2 部分：古籍证据梳理的标准化操作规程

1 范围

本标准规定了中医整体证据中古籍证据的构成和研究涵盖的内容。

本标准适用于中医药古籍经验证据的系统梳理和挖掘等。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

病（中医） Condition

即疾病，是致病邪气作用于人体，人体正气与之抗争而引起的机体阴阳失调、脏腑组织损伤、生理机能失常或心理活动障碍的一个完整的生命过程。

2.2

条文 citation

中医古籍中关于疾病认识、诊疗等信息分条说明的文字。

3 确定疾病相关的古籍检索词

3.1 疾病相关古籍检索词的范围

在确定检索词之前，应明确临床需求，构建临床问题，结合古籍特点，确定检索词。疾病相关的古籍检索词通常包括：疾病相应的古代病名；该疾病关键临床症状和体征相应古籍描述的词语。如果该疾病具有较为明确的古代病名，则直接检索全部对应的古代病名；如果该疾病的古代病名尚不明确，则列举该疾病关键临床症状和体征的名词。

3.2 确定疾病的古代病名

3.2.1 收集古籍病名

收集古籍病名的途径主要包括：

a) 古籍词典或中医辞典：查找相关名词的同义词或近义词；
b) 历史沿革的相关文献：检索该疾病认识、命名、治疗的相关文献，补充可能病名；
c) 古籍条文：通过阅读相关条文，补充该疾病相关的古代病名。

3.2.2 古籍病名的相似度分类

将上述途径收集的古籍检索词按其与疾病现代诊断相似度分为“与疾病现代认识相符”和“不确定或内涵太宽广”两类。在中华医典中预检索，记录每个检索词命中的古籍条文数，并试读部分命中的条文以判断其与疾病现代认识的相似度。

3.2.3 确定临床症状和体征的古代名词

公示稿

a）根据现代临床诊断标准列举该疾病的症状和体征；

b）选择较有把握确诊该疾病的特异性临床症状、体征及病史特征组合，并转换成古代可能描述的名词或词组；

c）转换名词或词组时应查找古籍词典，明确其确切含义；

d）参考相关书籍和期刊文献，补充可能的检索词；

f）在中华医典预检索，记录命中条文数，并试读部分命中的条文以判断其与疾病现代认识的相似度。

4 条文的纳入排除标准

a)全面回顾该疾病的诊断标准，参考以症状体征为主要诊断条件的标准；

b)确定特异性症状、体征可能有相应的古籍描述词语，通过这些词语可以判断该描述很可能是该疾病（即纳入标准）；

c)确定可能作为鉴别诊断的症状、体征相应的古籍描述词语，通过这些词语可以判断该描述与该疾病不相关（即排除标准）；

d)通过这些特异性和鉴别性词语的合理组合，拟定古籍条文可用的纳入排除标准；

e)对古籍条文中症状和体征进行编码，如：0=未提及该症状或体征，1=可能是该症状或体征，2=条文描述了该症状或体征；

f)在初始条文库中，抽取部分条文，应用上述拟定的纳入排除标准进行试判断筛选，根据测试结果，调整纳入排除标准。

5 《中华医典》第五版的检索及条文筛选

5.1 《中华医典》第五版界面

中华医典(湖南电子音像出版社)软件主界面左侧为书目结构树，右上方为检索操作区，右下方为检索命中条文显示区。可在左侧的书目结构树中选择特定的书目类型或范围进行检索。

5.2 检索步骤

以中华医典收录的全部古籍中检索“咳嗽”为例。

示例1：

a) 选定搜索节点：根据需要在左侧目录结构树选择节点并勾选“从选中节点中搜索”，或者不勾选直接从整个中华医典内搜索；

b) 选定检索范围：推荐“目录”（在结构树中包含书名、章节标题或内容等进行检索）或“正文”（在正文中进行检索）；

c) 检索及结果：检索框中输入“咳嗽”，单击“搜索”后有显示查找的结果数的弹出窗口，关闭窗口则书目结构树区则会列出本次检索结果；

公示稿

d) 条文查看：在书目结构树区域点击任意书目或章节标题，右侧的条文显示区则会展现正文的结果，正文最上一行红色字体显示的是条文的出处。

e) 结果合并及记录：在合并目录检索和正文检索的命中条文,并删除重复条文后，记录以上操作结果。

5.3 筛选确定初始条文库的条文

基于纳入排除标准和预检索的结果，删除与该疾病不相关检索词及其条文，确定初始条文库的条文，再筛选出与疾病现代认识高度相符的条文进行数据分析。如果没有高度相符的条文，可选择大部分描述相符的条文。在正式筛选前进行预筛选，两人独立筛选，两人意见不同时找第三方解决。

6 古籍数据处理

6.1 Excel 管理古籍条文

6.1.1 中华医典结果导出

中华医典可选择导出检索结果，也可重复手动复制条文到Excel中。每次只能复制当前页面显示的条文。

6.1.2 Excel整理及核对

检查确认已将在中华医典检索所得的全部条文汇总整理到Excel中,此处建议双人核对。对于重复的条文，同样导入到Excel文件中，但需明确标记。

6.1.3 Excel变量设置

除书名、章节、条文、检索词等变量外，还要设置条文序号、书籍编号、权重、条文分类、关键词、术语标注、作者、朝代等变量。

6.2 古籍条文查重原则

为了方便排除重复条文，Excel中的数据可按书名、章节和检索词进行排序，条文重复情况判定标准见附录A；有些条文里，一个症状名后附一系列方剂，每个方剂在Excel中需分开录入；当条文中仅提及方名但未描述组成，且该方剂组成有多个不同版本时，标记提及同一方剂的条文编号。此外，需使用统一的术语详细记录判定重复条文的原因。

6.3 数据编码

6.3.1 数据编码注意事项

采取双人独立对条文阅读并进行编码，然后核对两人编码的结果，对编码不同的条文，通过讨论和商量确定最终编码，并记录讨论结果。

6.3.2 单个症状和体征的编码

根据需要选择单个症状和体征作为分类标准，在Excel表中将其作为单独变量并进行编码。例如：如果选择的疾病有急性与慢性之分，那么“急性/慢性”就是一个分类标准，编码参考如下：0=没有提及急性或慢性、1=急性、2=慢性。

6.3.3 编码检索词

公示稿

为了记录每个检索词最终获得的条文数量，对命中每条条文的检索词进行编码。因为同一条条文可通过多个检索词检索到，所以将每个检索词作为单一变量标记，记录命中的条文。使用数字编码：0=该检索词未命中本条文、1=该检索词命中了本条文。

6.3.4 统一书名

收集目标条文时，往往会发现同一本书因出版年份、印刷版次或出版社的不同出现两个或两个以上的书名。因此需对书名进行标化，以避免数据分析产生缺漏或错误。

6.3.5 确定书本出版日期

书本出版日期是指写作年代或出版年代。对于已经确定书籍的成书或出版年代，这些可以直接采用；对于没有明确的，可选择作者死亡的年份、王朝灭亡的年份或根据参考资料推测最可能的年份。

6.3.6 标化或编码成书朝代

根据书名的整理结果，以及参考中华医典的成书朝代划分标准进行成书朝代的标化或编码。中华医典的成书朝代划分标准如下：

a) 唐代以前（618 年前）
b) 唐代及五代十国（618-960）
c) 宋金（960-1271）
d) 元（1271-1368）
e) 明（1368-1644）
f) 清（1644-1911）
g) 民国（1912-1949）
h) 现代（1950 至今）

6.3.7 编码方剂

如条文中出现方剂，则要对每个方剂进行对应编码。方名、组成都相同，或者组成相同方名相似的可用统一编码。而方名相同但组成不同则分配不同的编码，并在备注中用方名加数字区分，如归脾汤 1、归脾汤 2。

6.3.8 编码中药

将方剂按组成进行拆分，每味中药占据一个单元格。同一中药的不同名称，如薯蓣和山药，根据中国药典使用的中药名进行标化，保留原始记录。如药名对应不同的几味中药,例如：地黄、熟地黄和生地黄，则分别进行编码，分析时记录总体应用频数及各分类频数。

7 古籍数据分析

Excel筛选、编码完毕后导出到SPSS进行数据分析，分析前清理数据并检查数据的准确性，制定统计分析计划。

采用SPSS统计分析软件的语法（syntax）功能，并于开始分析前，设计好统计语法，记录分析的目的、分析的时间和分析语法。古籍条文常用数据分析有：

a) 对纳入条文中提及的方剂和中药进行频数分析；

公示稿

b） 根据相似度评分逐步选择相似度高的条文进行分析；

c） 根据分析的需要，使用“重新编码”（recode）功能，合并或生成新的变量；

d） 方剂组成的聚类分析。

8 古籍证据评价

针对古籍的证据评价，结合古籍的记载特点，考虑从古医籍来源的权威性、医家的资质、古籍记载的形式和内容的完善程度、古籍应用的传承性等方面进行评价，获得古籍证据评价结果，进而结合现代研究的证据进行临床决策。

公示稿

附录 A
（规范性附录）
判定为古籍重复条文的四种情况

A.1 一个检索词，如“肺胀”的条文在同一本书中可能出现两次。如果两处条文的内容相同，则明确标注为“与第 XX 条文相同”，且不需进行数据提取。

A.2 如书籍正文描述疾病或病案情况，并记录治疗方剂及其功效，具体组方详列在附录时，将这些信息合并为一个条文。附录的内容标记为重复。

A.3 两个检索词，如“肺胀”和“咳喘”的治疗在同一本书中使用了一个相同的方剂，条文不合并，但其中一条条文标记为重复。

A.4 因为中华医典书目编辑的原因，有些书目会重复出现，例如，《幼科证治准绳》和《证治准绳：幼科》，但两书其实是同一本书。

另外，一本书可能引用其他古籍的条文。但因为这是不同的书籍，因此不计为重复。重复类型 1、2 和 3，这些可以通过中华医典和书名排序找到。

公示稿

ICS ***
CCS ***

团 体 标 准

T/CACM XXX—2019

中医药整体证据研究的标准化操作规程
第 3 部分:现代研究证据梳理的标准化操作规程

Standard operating procedures of whole-evidence method for Chinese Medicine
Part 3:Standard operating procedures of modern literature

（稿件类型：公示稿）

（本稿完成时间：2020 年 3 月）

公示稿

201×-××-××发布　　201×-××-××实施

中 华 中 医 药 学 会发布

公示稿

公示稿

公示稿

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围..... 1
2　规范性引用文件..... 1
3　术语和定义..... 1
4　疾病认识的梳理方法..... 2
5　确定现代研究检索词..... 2
6　检索电子数据库..... 4
7　EndNote X6 文献管理 6
8　编码及数据提取..... 7
9　评价..... 8
10　临床前实验室药理研究证据梳理与汇总..... 9
11　整体证据汇总及推荐..... 10
附录 A（资料性附就）中医的疾病认识梳理示例 11
附录 B（资料性附就）西医疾病概述梳理示例 13
附录 C（资料性附就）干预措施和研究类型的英文检索词 14
附录 D（资料性附就）干预措施和研究类型的中文检索词 16
附录 E（资料性附就）题录分类编码..... 17
附录 F（资料性附就）英文数据库检索步骤 18
附录 G（资料性附就）中文数据库检索步骤 20
附录 H（资料性附就）Cochrane 偏倚风险评估工具 21
附录 I（资料性附就）PICO 评价示例 23
附录 J（资料性附就）证据总结表范例..... 24
附录 K（资料性附就）证据总结表相关定义和规范表达 25
参考文献 26

公示稿

前　　言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

T/CACM***《中医药整体证据研究的标准化操作规程》分为三个部分：

——第1部分：总则

——第2部分：古籍证据梳理的标准化操作规程

——第3部分：现代研究证据梳理的标准化操作规程

本部分为T/CACM***的第3部分。

本标准由中华中医药学会提出并归口。

本标准负责起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、澳大利亚皇家墨尔本理工大学(RMIT University)。

本标准参与起草单位：中国中医科学院中医临床基础医学研究所、上海中医药大学、北京中医药大学东直门医院。

本标准主要起草人：卢传坚、薛长利、郭新峰、张林、温泽淮、刘少南、Brian May、谢雁鸣、王拥军、商洪才、杨丽虹、Meaghan Coyle、李慧、陈婧、Johanna Shergis、谢秀丽、Claire Zhang、何怡瀚、Yuan Ming DI、赖佳琪。

公示稿

引　言

现代研究证据采用国际公认的系统评价研究方法，系统地梳理中医药治疗包括随机对照试验、非随机对照试验、无对照研究等各个类型的证据，标准内容包括检索词的制定、文献的筛选管理、文献的方法学质量评价等内容，并涵盖实验室研究证据等支持性证据的系统收集、整理，将为临床呈现更加客观全面的中医药治疗证据，有助于推动中医药临床实践和循证医学的发展。

公示稿

公示稿

中医药整体证据研究的标准化操作规程

第 3 部分：现代研究证据梳理的标准化操作规程

1 范围

本标准规定了中医药现代临床研究证据的梳理内容。

本标准适用于中医药循证临床实践指南的制修订等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Cochrane 偏倚风险评估工具

GRADEpro 手册 http://www.guidelinedevelopment.org/handbook

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

Meta 分析 Meta-analysis

在系统评价中使用统计学方法来合并纳入研究的结果。有时会被误认为是系统评价的同义词，系统评价通常包括Meta分析。

3.2

随机对照试验 Randomized Controlled Trial, RCT

将两种或两种以上的干预措施(可包括对照干预措施或无干预措施)随机分配给受试者进行比较的试验。大多数情况下，一种干预措施被分配到一个单独的个体，但有时也被分配到某个特定群体里中的个体(例如，一个家庭中的个人)，或干预措施分配到一个单独的个体自身(例如，干预措施在同一个体干预的先后不同顺序或干预措施分配在同一个体自身的不同身体部位)。

3.3

非随机对照试验 Non-randomized study

任何评估干预措施(危害或益处)有效性的但没有使用随机化将受试单位（个体或群体）分配到不同比较组的定量研究。这包括队列研究、病例对照研究、前后对照研究等。

3.4

偏倚风险 Risk of Bias, RoB

偏倚风险是指结果或推论中发生系统性错误或偏离真实值的风险，通常指在研究的设计、实施、分析和报告过程中产生的系统误差。

公示稿

3.5

系统评价 Systematic review

对一个明确提出的临床问题使用系统的、明确的方法来检索、筛选和客观地评价相关研究，并收集和分析纳入研究的数据的一种综述。可用或不用统计学方法(Meta分析)分析和合并纳入研究的结果。

4 疾病认识的梳理方法

4.1 疾病的中医认识

中医对疾病的认识包括病因病机、辨证分型、诊断、治疗、预防调摄等信息，可参考教科书、专著和指南进行相关内容的梳理。其中，教科书包括国家制定的供中医和中西结合专业本科生和研究生使用的规范教材。

中医指南或中西医结合指南则通过数据库检索，检索时检索词应包括："指南""标准""共识""路径"以及疾病名称、中医（含中药、其他中医疗法、预防调摄）等。具体中医的疾病认识梳理的表格记录示例见附录A。

关于病因病机的源流，除了参考教科书、专著和指南，必要时可参考《中华医典》梳理相关内容。最终，病因病机的源流需通过专家咨询达成共识。

4.2 疾病的西医认识

西医的疾病概述包括西医流行病学、危险因素、诊断、防治、并发症等信息，可通过检索教科书、指南、文献数据库、政府网站等参考资料来收集以上信息。

流行病学资料的内容应当包括患病率、发病率、疾病负担、直接经济负担、间接经济损失等。西医疾病概述参考资料整理记录参照附录B。

5 确定现代研究检索词

在确定现代研究检索词前，应基于研究的目的构建临床问题，从临床研究的PICO核心要素结合研究类型制定纳入排除标准，然后进行检索筛选和评价。

5.1 收集病名检索词

5.1.1 英文病名检索词

5.1.1.1 英文电子数据库检索

通过英文电子数据库检索收集英文病名有以下几种方式：

a) Cochrane Library 数据库：参考系统评价和研究方案检索策略中的"病名"检索词，或参考Cochrane Review Group相关文献使用的检索策略；

b) PubMed 数据库：在MeSH 主题词检索框输入疾病名称，根据需要选择是否拓展检索词，注意最后一次MeSH主题词修订时间；

c) Embase 数据库：在Emtree 主题词检索界面中选择"Advanced"，在检索框中输入检索词，在"Mapping"中根据需要选择是否拓展检索，单击"Search"。

5.1.1.2 其他查找方式

公示稿

查找非Cochrane 系统评价中的病名相关检索词；查找病名相关文献中的关键词；用病名名称的拼音进行检索。

5.1.2 中文病名检索词

5.1.2.1 检索相关文献

如果疾病在古代有相应病名，则要查找该疾病在古籍和现代中医类文献中出现的中医病名，具体操作请参考5.1。除此之外，参考研究疾病相关系统评价获取检索词，查找现代中医、中西医、西医教科书，也是收集该疾病的现用病名的有效途径。

5.1.2.2 中文电子数据库查找

通过中国生物医学数据库（SinoMed）的主题词功能，查找相应的主题词及上下位词，维普、知网等数据库通过查找同义词及检索历史模块，确定相应的近义词或同义词。

5.1.2.3 其他查找方式

使用上述关键词、同义词或近义词进行检索；文献下载筛选后，查看文献的摘要、全文、参考文献补充病名检索词。

5.2 收集干预措施和研究类型的检索词

收集干预措施和研究类型的确定操作与病名检索词一样，英文检索词可参考附录C，中文检索词参照附录D。需注意在不同的数据库时需根据数据库特点调整整个检索式的格式和结构。

5.3 检索词筛选

查找到的所有检索词都要进行记录，创建检索词筛选列表，然后根据查找结果命中数以及抽查准确性确定纳入与排除的情况。如果一个词包含另一个检索词，则应当将另一个检索词排除。如无法判断，用“AND”逻辑式连接这两个检索词进行预检索。如果检索数量与其中一个检索词的相同，则证明该检索词包含另一个检索词；如果检索数量小于任一检索词的结果，则两个检索词是交叉关系，均无需排除。

示例2：

日期	数据库	检索词	命中数	是否纳入	排除原因
YYYY-MM-DD					

5.4 制定检索策略

针对上述疾病、干预措施、研究类型3类检索词，制定检索策略时一般有分步骤检索及检索式检索。

示例3：

#1 “Psoriasis”
#2 “Psoriasis vulgaris”
#3 “Pustular psoriasis”
#4 “Acupuncture”

公示稿

#5 “Chinese medicine”
#6 “Meta analysis”
#7 “Systematic review”
#8 #1 OR #2 OR #3
#9 #4 OR #5
#10 #6 OR #7
#11 #8 AND #9 AND #10

检索式检索则是将检索词之间用布尔逻辑运算符“OR”“AND”“NOT”连接。与分步骤检索一样，同类检索词之间用“OR”连接，不同分类检索词用“AND”连接。又因为运算顺序（ ）> NOT> AND > OR，所以要先将同类检索词用括号括起来再与其他类检索词“AND”连接。一般不建议使用“NOT”，因为数据库定义的主题词未必符合研究目的，不利于检索结果的全面性。

5.5 检索式的预检索及修改

a）通过预检索检测检索策略的全面性，是否存在文献漏检的情况。

b）在相关出版物的参考文献中查漏补缺。如果预检索未能检出出版物引用的文献，可在PubMed或SinoMed中检索该文献以确定它是否被标引。若已被标引，但预检索未能检出，进一步完善检索策略。

c）对检索策略进行修改时，要将修改后的检索策略另存为新文件，并标注修正的原因。每次检索词的预检索都要记录检索结果并根据结果的数量及准确性判断是否保留。

示例4：

日期	数据库	检索式	命中数	是否保留
YYYY-MM-DD				

6 检索电子数据库

6.1 检索结果记录

通过在线数据库检索研究相关信息可以较大程度的避免手动检索的失误与缺漏，减少人力、物力及时间的耗费，根据研究目的使用数据库的检索限制更是事半功倍。需要留意的是，各数据库检索的更新时间、标引规则等管理的不一致导致检出结果数量不一，因此每次电子数据库检索我们要对检索结果做记录。

示例6：

日期	数据库	检索式	命中数
YYYY-MM-DD			

公示稿

6.2 英文数据库检索

根据Cochrane系统评价手册中的方法，检索目前最常用、涵盖全面的英文数据库。大部分英文数据库除了检索及结果导出外，登录其注册账号后能使用保存检索式功能。该功能可以根据已被检过的检索式定期或不定期的多次检索，查找出自上一次检索后数据库更新的文献数据，有利于文献评价的及时更新。各英文数据库检索步骤可参考附录F。

6.3 中文数据库检索

中医药的研究目前主要发表在中文期刊上，因此选择系统评价最常用的四大数据库作为主要证据来源。各中文数据库检索步骤可参考附录G。另外，使用中文数据库检索需注意：

a) 各个中文数据库的字段定义范围各不相同，要根据数据库检索说明或检索测试以及自身研究目的选择适合的检索字段；

b) 中文数据库偶尔也存在词组拆分检索的情况，如果影响到了检索结果的准确性，建议与英文数据库检索一样给检索词加上英文半角的引号；

c) 较之于英文数据库，中文数据库的升级改版情况相对频繁，所以使用时要多留意数据库的新功能设置及说明。

6.4 文献题录导出

6.4.1 基本步骤

文献题录导出基本步骤如下：

a) 检索结果按发表时间排序，以防因网络稳定性或其他问题导致导出题录的重复或缺漏；

b) 将每页显示设置为数据库允许的最高上限，尽可能减少页面切换；

c) 全选当前页的所有文献结果，按顺序翻页重复此操作直至达到数据库每次导出题录的数量上限；

d) 点击含“导出”二字的操作选项，在文献导出格式中均选择“EndNote”并单击“导出”，SinoMed数据库除外；

e) 重命名导出生成的TXT文件，并保存在本地计算机；

f) 将原已选文献的记录清除，翻页重复以上操作直至导出所有题录。

每次导出题录数量的上限：中国生物医学文献数据库及中国知网不超过500条，万方数据知识服务平台及重庆维普数据库不超过50条。

6.4.2 SinoMed 导出内容设置

a) 单击检索结果列表右上方的“结果输出”；

b) 在“选择输入方式”项目中选择“保存”；

c) 在“选择保存格式”项目中选择记录号，并填写与所需输出结果对应的记录号；

d) 在“选择保存格式”项目中选择“自定义”，将弹出子项目“选择字段”，勾选：标题、摘要、关键词、作者、作者单位、出处，然后单击“确定”。

公示稿

7 EndNote 文献管理

7.1 导入题录

7.1.1 导入设置

EndNote导入文献的方法有很多，此处主要介绍TXT格式转换的题录导入方法。打开或新建Endnote Library，单击“File”> “Import File”将弹出相应窗口，根据需求设置“Import File”弹出窗口的选项。弹出窗口各项说明如下：

a) Import File即选择拟导入的文件；

b) Import Option即选择拟用的过滤器，将在下文详细讲解；

c) Duplicates即选择处理重复文献的方法，一般选择默认的Import ALL，也可选择Discard Duplicates；

d) Text Translation即选择编码转换方式，可根据实际需要或导入结果出现乱码来进行选择。

7.1.2 过滤器的选择

当从TXT格式转换题录导入题录时，除SinoMed要自建过滤器外，EndNote里有不同数据库对应着的不同过滤器，“Import Option”的具体选择见下表：

电子数据库	过滤器
Embase	Embase（OvidSP）
PubMed	PubMed (NLM)
AMED	AMED（OvidSP）
中国知网、万方数据知识服务平台、重庆维普数据库	Endnote Import

当合并多个EndNote 库到一个主库时，“Import Option”选择“Endnote Library”。建议各数据库题录分开新建EndNote Library导入，各数据库单独除重后，再合并除重。

7.1.3 制作 SinoMed 题录过滤器

由于SinoMed题录导入格式在EndNote没有对应的过滤器，因此需要研究者根据研究目的创建，操作方法（略）。

7.2 题录除重

a) 单击“Edit”> “Preferences”；

b) 在弹出窗口“EndNote Preferences”选择“Display Fields”模块以设置Library界面显示内容；

公示稿

c） 推荐的界面显示字段主要包括：Author、Year、Title、Journal、Abstract、Rating等；

d） 研究者可根据Author、Title、Year等主要字段，通过不同的组配方法完成文献的除重

e） 因为各数据库导出的题录在标点符号、空格或字母大小写上有所差异，EndNote系统自动查重无法检测，所以在经过系统自动除重后，可选择进一步手动查重。

7.3 题录导出（TXT 文件）

a） 单击“File”> “Export File”；

b） 设置“保存类型”：一般保持默认的“Text File（*.txt）”选项；

c） 设置“Output style”：可根据系统提供的格式在下拉框里选择，也可建立新的导出格式（具体操作略）。

8 编码及数据提取

8.1 题录编码

8.1.1 按治疗措施分类编码

根据文献报道的治疗措施进行分类编码。

示例7：

a） E，与中医治疗不相关的题录；

b） H，中药治疗类的题录；

c） A，针灸及其他于穴位相关的治疗类题录；

d） O，其他如太极、导引等中医疗法治疗类的题录；

e） B，中医疗法联合西医疗法的治疗类题录；

f） U，根据标题和摘要仍无法确定分类的题录。

8.1.2 按研究类型分类编码

根据文献类型进行分类编码。

示例8：

a） S，系统评价；

b） G，综述；

c） R，随机对照试验；

d） C，对照试验。

更具体的题录编码细则请参考附录E。在进行全文下载、浏览后再最终判断题录编码，尤其是U编码的题录。最终纳入的文献题录用“Y”标记。

公示稿

8.2 数据提取

文献数据提取一般耗时较长，通常需提前制定工作计划，以提高工作效率，避免工作重复。根据研究目的、纳入排除标准和纳入文献数据特征建立数据提取表，然后按照以下几个注意事项提取数据：

a) 特殊语种：所有数据应以原始语言提取，对于非英语或非中文的文献，可请专人协助数据提取；

b) 单元数据：提取数据时确保每个单元仅输入一个数据以便必要时排序，如果该变量无数据，则输入'NS'（NotSpecified）；

c) 方剂名及中药名：方剂名称及其组成中药名需完全按照文献中的描述提取，且使用与原文献相同的语言,必要时可对其进行编码和分类，以便于统计分析；

d) 检索日期:为便于识别数据来自原始记录和后续检索的记录,标注提取或检索日期；

e) 数据提取操作：两人各自独立同时进行数据提取，提取完成后进行结果对比，检查录入数据一致性，若有异议必要时请第三人共同协查。

8.3 数据编码

在现代和古籍文献数据分析中，常采用数据编码系统地处理数据，将其拆分成较小的可分析单元，以便于统计分析。编码簿创建需做到以下几点：

a) 列出纳入分析的所有变量类型及其所有可能的分类；

b) 变量名位于首列，命名尽可能简短；

c) 对每个变量进行赋值（通常为数值），提前定义缺失值的编码，如NA（Not Applicable）；

d) 将编码簿作为单独文档保存为Microsoft Excel工作表，使用前复制该文件。

9 评价

9.1 偏倚风险评估（RoB）

随机对照试验的偏倚风险评估采用Cochrane系统评价手册的偏倚风险评估工。Cochrane偏倚风险评估工具包括以下7个条目：

a) 随机序列的产生(选择偏倚)；

b) 分配隐藏(选择偏倚)；

c) 研究参与者和受试者采用盲法(执行偏倚)；

d) 结果评估者采用盲法(观察偏倚)；

e) 结果数据的完整性(失访偏倚)；

f) 选择报道(报告偏倚)；

g) 其他。

公示稿

根据附录H中详细描述的评价标准，评价各条目可能存在偏倚为“低风险”或“高风险”或“不清楚”，并给出判断依据。以文字、表格或图示方法显示所有纳入文献的评价结果。

针对非随机对照研究的偏倚风险评估，针对不同研究类型，偏倚风险工具较多，如Newcastle-Ottawa scale[1]，Downs-Black工具[2]，ROBINS-I等[3]，部分工具尚处于初步使用和完善阶段，具体内容参见相关的说明手册及国内学者的解读[4,5]。

9.2 证据质量评价与结果的呈现

9.2.1 研究要素的重要性评价

a) 以研究问题和结局指标重要性制定PICO评级表格，参考示例见附录I；

b) 组建评价小组，该小组应该由临床专科人员、方法学研究人员和临床咨询专家组成；

c) 评价小组所有成员独立地评价PICO评级模板中各条目重要性；

d) 随后汇总成员组意见，通过会议对做出最后的决定。

9.2.2 证据总结表创建

证据总结表可在GRADEpro网站完成。步骤如下：

a) 登陆其网址http://www.gradepro.org；

b) 选择“新建”或从RevMan“导入”项目来制作证据总结表；

c) 根据分级标准得出结论，具体操作可参考GRADEpro手册（http://www.guidelinedevelopment.org/handbook）；

d) 证据总结表范例可见附录J，而证据总结表相关定义和规范表达可参照附录K。

10 临床前实验室药理研究证据梳理与汇总

10.1 证据梳理

查找研究疾病相关文献明确发病机制和通路。若发病机制通路未知或不明确，则明确治疗药物的作用途径及其代表性作用机制，例如皮质类固醇和抗肿瘤坏死因子药物。明确中药作用途径的检索步骤：

a) 检索中医、西医全国统编教材(供本科生或研究生使用)和《中药大辞典》。

b) 明确中药的植物学名、拉丁文名和活性成分（分类归纳）。

c) 使用相关检索词检索PubMed 和EMBASE。

将检索结果根据以下纳入标准进行筛选：①动物模型实验研究，如烟雾诱发的小鼠COPD模型；②细胞学分子学实验研究，如肺上皮细胞因子通路；③近期发表在高影响因子期刊上的研究；或研究疾病领域专家发表的相关综述。

10.2 证据总结

主要包含以下内容：

a) 描述中药名及其活性化学成分，例如甘草主要活性成分是三萜类化合物，这包括甘

公示稿

草甜素、黄酮类、生物碱和其他化学成分如甘草次酸等；

b） 归纳总结与研究疾病治疗相关的活性成分作用机制，如在急性肺炎小鼠动物模型中，黄酮类化合物甘草甙、甘草苷以及甘草素分别以 30mg/kg 灌胃均可减少支气管肺泡灌洗液中嗜中性粒细胞、巨噬细胞和淋巴细胞的数量；

c） 根据纳入研究亮点和重点进行讨论，例如某中药现有实验研究证据阐明的某些药理作用和机制在某临床试验中也得到了印证。

11 整体证据汇总及推荐

11.1 整体证据汇总

将中医指南或教科书推荐的方药及针灸等疗法、古籍中常用的方药及针灸疗法、现代临床研究中常用的方药及针灸等疗法的证据进行客观的汇总呈现。

11.2 证据推荐

结合目前的指南、古籍及现代研究证据，综合考虑卫生资源配置、利弊权衡、患者的意愿等因素，同时结合医生的经验，做出临床推荐。当推荐意见不一致时，可采用德尔菲法或名义群体法等共识方法达成一致，也可参照应用GRADE网格对推荐意见达成共识。

公示稿

附录 A
（资料性附录）
中医的疾病认识梳理示例

表A.1至表A.6分别给出了梳理中医疾病的病因病机、辨证分型、诊断、中药治疗、其他中医治疗、以及预防调护时，所需关注并记录的内容示例。

表A.1为中医病因病机的认识梳理内容示例。

A.1 病因病机

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	中医病因病机	备注
中医循证临床实践指南•中医内科	中国中医药出版社	2011年1月	第1版	诱因为反复感受风寒、风热之邪，以及过劳、吸烟、情志刺激等。病机总为本虚标实，虚实夹杂。	以下简称临床指南，该书涵盖18种内科常见病，分3册。
慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南	中医杂志	2012年	2011版	急性加重期病机为痰（痰热、痰浊）阻或痰瘀互阻，常兼气虚或气阴两虚，虚实相互影响，以痰瘀互阻为关键。稳定期病机以气（阳）虚、气阴两虚为主，常兼痰瘀。	共识指南以期刊文献的形式发表。

表A.2为辨证分型的认识梳理内容示例。

A.2 辨证分型

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	辨证分型	备注
中医循证临床实践指南•专科专病	中国中医药出版社	2011年1月	第1版	血热证、血瘀证、血燥证为寻常型银屑病的主要证型	寻常型银屑病中医临床实践指南

表A.3为中医诊断的认识梳理内容示例。

A.3 诊断

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	诊断	备注
中医循证临床实践指南•中医内科	中国中医药出版社	2011年1月	第1版	肺胀，喘证	以下简称临床指南，该书涵盖18种内科常见病，分3册。
慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南	中医杂志	2012年	2011版	咳嗽，喘病，肺胀	共识指南以期刊文献的形式发表。

公示稿

表 A.4 为中药疗法的认识梳理内容示例。

A.4 治疗（中药）

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	中药治疗	描述
中医循证临床实践指南•专科专病	中国中医药出版社	2011 年 1 月	第 1 版	常用治疗方法： 1. 从血论治 ①清热凉血解毒法②活血化瘀法：血府逐瘀汤、桃红四物汤③养血消风法； 2. 从脏腑论治 ①从肺论治②从脾肾论治：健脾益肾汤，③从肝论治：逍遥丸、加味逍遥汤龙胆泻肝汤； 3. 中医辨证治疗： 血热证之克银一方、消银颗粒、清开灵注射液；血燥证之克银二方、消银颗粒； 血瘀证之血府逐瘀汤、大黄蛰虫丸、丹参注射液	寻常型银屑病中医临床实践指南

表 A.5 为其他中医疗法的认识梳理内容示例。

A.5 治疗（其他疗法）

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	其他疗法	描述
中医循证临床实践指南•中医内科	中国中医药出版社	2011 年 1 月	第 1 版	针灸，穴位贴敷，内服中药结合呼吸操和推拿，八段锦，气功，中药熏洗双足	以下简称临床指南，该书涵盖 18 种内科常见病，分 3 册。
慢性阻塞性肺疾病中医诊疗指南	中医杂志	2012 年	2011 版	单方验方，针灸，拔火罐，穴位贴敷	共识指南以期刊文

表 A.6 为预防调摄的认识梳理内容示例。

A.6 预防调摄

书名/指南	出版社/期刊	年份	版次	预防调摄	描述
中医循证临床实践指南•专科专病	中国中医药出版社	2011 年 1 月	第 1 版	1.心理护理；2.饮食护理；3.避免感染、外伤；4.纠正不良生活习惯；5.其他生活护理	寻常型银屑病中医临床实践指南

公示稿

附录 B
（资料性附录）
西医疾病概述梳理示例

B.1 教科书

可查找国家出版的规范化教材，英文材料参考默沙东诊疗手册（在线版）：http://www.merckmanuals.com/professional/index.html 、或中文版 CD-ROM。

B.2 指南

可查阅国家临床指南文库、医脉通、国内学会网站、国外的指南数据库及平台网站(GIN、NGC、NICE、WHO 等)。

B.3 现代文献

可查阅 The Cochrane Library、PubMed、Embase、JBI CONNECT Plus 等数据库查阅。

B.4 国家或学术组织网站

可参阅下表：

国家	组织	URL 地址
美国	Centres for Disease Control and Prevention (CDC)	www.cdc.gov
英国	Office for National Statistics	http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
澳大利亚	Australian Institute for Health and Welfare (AIHW)	http://www.aihw.gov.au
	Australian Bureau of Statistics (ABS)	www.abs.gov.au
中国	Chinese Center for Disease Control and Prevention	http://www.chinacdc.cn/en/
欧洲	European Centre for Disease Control	http://ec.europa.eu/health/index_en.htm
全球数据	World Health Organisation	

B.5 其他

如果仍不能获得有效信息，也可查阅：http://www.epibiostat.ucsf.edu/epidem/epidem.html 该网站提供的内容包括政府机构、国际组织、专业协会、肿瘤、心血管疾病、糖尿病、感染性疾病和艾滋病，以及循证医疗保健。

公示稿

附录 C
（资料性附录）
干预措施和研究类型的英文检索词

表C.1给出了PubMed 和Embase两个英文数据库干预措施和研究类型的检索词。

表 C.1 PubMed 和 Embase 中干预措施和研究类型的英文检索词

类型	检索词	PubMed	Embase
干预措施	中药	“Traditional Chinese Medicine” OR “Chinese Traditional Medicine” OR “Chinese Herbal Drugs” OR “Chinese Drugs, Plant” OR “Medicine, Traditional” OR “Ethnopharmacology” OR “Ethnomedicine” OR “Ethnobotany” OR “Medicine, Kampo” OR “Kanpo” OR “TCM” OR “OR Medicine, Ayurvedic” OR “Phytotherapy” OR “Herbology” OR “Plants, Medicinal” OR “Plant Preparation” OR “Plant Extract” OR “Plants, Medicine” OR “Materia Medica” OR “Single Prescription” OR “Herbs” OR “Chinese Medicine Herb” OR “Herbal Medicine”	‘Chinese medicine’ OR ‘medicinal plant’ OR ‘Chinese drug’ OR ‘plant medicinal product’ OR ‘plant extract’ OR ‘herb’ OR ‘herbal medicine’ OR ‘material medica’ OR ‘traditional medicine’ OR ‘ethnopharmacology’ OR ‘ethnobotany’ OR ‘Kampo’ OR ‘Avuryeda’ OR ‘alternative medicine’ OR ‘phytotherapy’
	针灸及相关疗法	“Acupuncture” OR “Meridians” OR “Electroacupuncture” OR “Moxibustion” OR “Auriculotherapy” OR “plum blossom” OR “acupressure” OR “moxa” OR “laser acupuncture” OR “seven star needle” OR “electro-acupuncture” OR “TENS” OR “transcutaneous nerve stimulation” OR “transcutaneous electric nerve stimulation” OR “transcutaneous electrical nerve stimulation” OR “electro-stimulation” OR “electro stimulation” OR “pharmacopuncture” OR “point injection” OR “catgut embedding”	‘acupuncture’ OR ‘electroacupuncture’ OR ‘moxibustion’ OR ‘plum blossom’ OR ‘acupressure’ OR ‘moxa’ OR ‘seven star needle’ OR ‘electro-acupuncture’ OR ‘TENS’ OR ‘transcutaneous nerve stimulation’ OR ‘transcutaneous electric nerve stimulation’ OR ‘transcutaneous electrical nerve stimulation’ OR ‘electro-stimulation’ OR ‘electro stimulation’ OR ‘pharmacopuncture’ OR ‘point injection’ OR ‘catgut embedding’
	其他中医疗法	“Tai Ji” OR “Tai chi” OR “Breathing exercises” OR “Qi gong” OR “Qigong” OR “Chi Kung” OR “Tuina” OR “anmo Tuina” OR “Chinese massage” OR “cupping” OR “guasha” OR “blood letting” OR “bloodletting” OR “diet therapy” OR “therapies, diet” OR “phlebotomy”	‘Tai Chi’ OR ‘Tai Ji’ OR ‘Breathing exercise’ OR ‘Qi gong’ OR ‘Qigong’ OR ‘Tuina’ OR ‘anmo Tuina’ OR ‘Chinese massage’ OR ‘cupping’ OR ‘guasha’ OR ‘blood letting’ OR ‘bloodletting’ OR ‘Diet therapy’ OR ‘diet treatment’ OR ‘dietary therapy’ OR ‘dietary treatment’ OR ‘Phlebotomy’

公示稿

表 C.1 PubMed 和 Embase 中干预措施和研究类型的英文检索词（续）

类型	检索词	PubMed	Embase
研究类型	随机对照试验[a]（含半随机对照试验）	“randomized controlled trial”[pt] OR “controlled clinical trial”[pt] OR “randomized”[tiab] OR “placebo”[tiab] OR “drug therapy”[sh] OR “randomly”[tiab] OR “trial”[tiab] OR “groups”[tiab]	‘randomized controlled trial’/exp OR ‘controlled clinical trial’/exp OR ‘randomized’:ti，ab OR ‘placebo’:ti，ab OR ‘drug therapy’:lnk OR ‘randomly’:ti，ab OR ‘trial’:ti，ab OR ‘groups’:ti，ab
	系统评价[b, c]	“Systematic” [sb]	meta-analys:.tw. OR search:.tw. OR review.pt
	其他 d[4]	“cohort studies”[mesh] OR “case-control studies”[mesh] OR “comparative study”[pt] OR “risk factors”[mesh] OR “cohort”[tw] OR “compared”[tw] OR “groups”[tw] OR “case control”[tw] OR “multivariate”[tw] OR “case series”	‘clinical article’/exp OR ‘controlled study’/exp OR ‘major clinical study’/exp OR ‘prospective study’/exp OR ‘cohort analysis’/exp OR ‘cohort’:ti，ab OR ‘groups’:ti，ab OR ‘case control’:ti，ab OR ‘multivariate’:ti，ab OR ‘case series’:ti，ab

[a] 来源：The Cochrane Library
[b] 来源：http://www.nlm.nih.gov/bsd/pubmed_subsets/sysreviews_strategy.html
[c] 来源：Wilczynski et al 2007 (92.3% 敏感度，87.7% 特异度)
[d] 来源：http://hms.harvard.libguides.com/content.php?pid=131718&sid=1791604

公示稿

附录 D
（资料性附录）
干预措施和研究类型的中文检索词

表D.1 列出了中医相关疗法和研究类型的检索词。

表 D.1 中医相关干预措施和研究类型的中文检索词

类型	类型	检索词
干预措施	中药	中医 OR 中西医 OR 中医疗法 OR 辨病论治 OR 辨证 OR 辨证论治 OR 辨症施治 OR 汉方 OR 祖国医学 OR 传统医学 OR 传统治疗 OR 替代医学 OR 替代治疗 OR 中国传统医学 OR 民族医药 OR 草药 OR 中草药 OR 中药 OR 中药疗法 OR 中西药 OR 传统医药 OR 中成药 OR 植物药 OR 中医治法 OR 熏洗 OR 药浴 OR 沐足 OR 足浴 OR 灌肠 OR 熨法 OR 药熨 OR 熨药 OR 热熨 OR 热敷 OR 敷脐 OR 药枕 OR 药烘
	针灸及相关疗法	针刺 OR 灸 OR 针法 OR 刺法 OR 体针 OR 腹针 OR 温针 OR 火针 OR 电针 OR 电磁针 OR 梅花针 OR 水针 OR 穴位注射 OR 经络注射 OR 穴位按压 OR 穴位按摩 OR 指压穴位 OR 耳压 OR 耳针 OR 耳穴 OR 耳豆 OR 埋藏疗法 OR 埋线
	其他中医疗法	外治 OR 推拿 OR 按摩 OR 拔罐 OR 药罐 OR 推罐 OR 闪罐 OR 电罐 OR 火罐 OR 砭石 OR 砭术 OR 砭法 OR 刮痧 OR 刮搓 OR 挑治 OR 割治 OR 发泡 OR 导引 OR 吐纳 OR 气功 OR 太极 OR 八段锦 OR 刺络 OR 刺血 OR 放血 OR 三棱针
研究类型	系统评价	系统综述 OR meta OR 荟萃分析 OR 系统分析 OR 综述 OR 进展 OR 概况 OR 现状 OR 近况
	临床试验 （包括随机对照试验、非随机对照试验、无对照研究）	临床观察 OR 临床评估 OR 临床试验 OR 临床效果 OR 临床研究 OR 疗效 OR 评价研究 OR 前瞻性 OR 随访 OR 对比研究 OR 多中心 OR 随机 OR 对照 OR 病例报告 OR 病例研究 OR 病例分析 OR 病例报道
注：与英文数据库不同，不同中文数据库的检索界面和功能差异更大。虽然大多数数据库可使用“+”和“-”逻辑连接符，但少数数据库不支持布尔逻辑运算符或较复杂的检索式。		

公示稿

附录 E
（资料性附录）
题录分类编码

表E.1列出了文献筛选时题录的分类编码。

表 E.1 文献筛选题录分类编码

分类	编码	编码描述	研究类型	类型描述
不相关	E1	与研究疾病无关	-	
	E2	非中药	-	
	E3	非临床研究（动物细胞分子实验等）	-	
	E4	其他	-	
中药	H1	系统评价	S/G	S：中药系统评价 G：中药综述
	H2	随机/非随机对照试验	R/C	R：中药随机对照试验 C：中药对照试验
	H3	无对照研究	-	-
针灸及相关研究	A1	系统评价	S/G	S：针灸系统评价 G：针灸综述
	A2	随机/非随机对照试验	R/C	R：针灸随机对照试验 C：针灸对照试验
	A3	无对照研究	-	-
其他中医疗法	O1	系统评价	S/G	S：其他中医疗法系统评价 G：其他中医疗法综述
	O2	随机/非随机对照试验	R/C	R：其他中医疗法随机对照试验 C：其他中医疗法对照试验
	O3	无对照研究	-	-
中医联合疗法	B1	系统评价	S/G	S：中医联合疗法系统评价 G：中医联合疗法综述
	B2	随机/非随机对照试验	R/C	R：中医联合疗法随机对照试验 C：中医联合疗法对照试验
	B3	无对照研究		-
专家意见	U	不清楚		研究类型及干预措施不清楚

公示稿

附录 F
（资料性附录）
英文数据库检索步骤

F.1 至 F.5 给出了 PubMed、Cochrane、Embase、AMED、CINAHL 数据库的检索步骤。

F.1 PubMed 数据库

F1.1 基本检索步骤

a) 通过网址 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed(或 www.pubmed.com)登陆 PubMed 数据库检索界面，注意在检索框左侧选择数据库来源为 PubMed；

b) 检索操作可以是各个检索词单独检索后再“Advance”增加“OR”、“AND”逻辑连接的分步骤检索，也可以是在“Advance”里“Edit”编辑复杂逻辑检索式后进行直接检索；

c) 所有检索结果可在“Advanced Search Builder”的“items found”查看。

F1.2 文献题录导出

a) 通过点击 “Send To”进行文献题录导出；

b) 建议将导出设置“Choose Destination”、“Format”、“Sort by”分别定义为“File”、“MEDLINE”、以及“Most Recent”；

c) 最后单击“Create File”重命名并保存文件即可。

F.2 Cochrane 对照试验中心注册库

F2.1 检索操作

a) 通过网址http://www.cochranelibrary.com/进入其官网，一般采用“Advanced Search”高级检索功能；

b) 选择字段检索范围，如“All text”；

c) 该数据库能自动匹配检索词，根据需要选择相应的匹配检索词即可；

d) 相较于其他综合性数据库，Cochrane对照试验中心注册库(CENTRAL)主要包含与系统评价相关的临床试验，因此CENTRAL检索不需要检索研究类型检索词；

e) 如有多个检索词，点击“+”添加检索词，最多可添加五个检索词。

F2.2 文献题录导出

a) 通过Cochrane检索结果列表的最上端的“Export all”链接就能进行文献题录导出；

b) 建议将导出设置“Export type”、“File type”分别定义为“PC”、“Citation and Abstract”；

c) 最后单击“Export Citaiton”重命名并保存文件即可。

F.3 Embase

F3.1 快速检索

a) 在Embase主页的“Search”模块选择菜单中的“Quick”即可实现快速检索。

b) 选择“Quick search”、“Journal name”、“Author name”、“Author’s first name”中任意一个字段的四个检索框，可根据需要增减检索框，也可在下拉框选择相应的检索字段；

c) 其中“Quick search”在“All fields”字段检索的基础上又加了检索词的拓展检索，因此“Quick search”较其他字段检索得更全面，但使用时需要检测其准确性。

F3.2 高级检索

a) 在“Search”模块，选择菜单中的“Advanced”进入高级检索界面；

公示稿

b) 检索框内输入检索式，可以参照数据库提供的示例通过检索框下方的“Fields”限定检索字段，也可以在检索词后输入“/exp”进行检索词拓展；

c) 勾选所需检索限定选项，选项包括“Mapping”、“Date”、“Sources”、“Quick limits”、“EBM”、“Pub.types”、“Languages”、“Gender”、“Age”等。

F3.3 文献题录导出

a) 在“Results”模块的“History”选定检索出目标题录的相应检索式；

b) 勾选检索结果点击“Export”；

c) 设置“Export Data”弹出窗口的“Choose a format”为“RIS format(Mendeley, Endnote)”， 单击“Export”完成题录导出；

d) 重命名并保存文件即可。

F.4 AMED (Allied and Complementary Medicine Database)

F4.1 检索步骤

a) 进入AMED主页，点击检索框下方的“Advanced Search”进入高级检索界面；

b) 在检索框内输入检索词，右侧下拉菜单选择相应的检索字段，点击“+”可添加检索词；

c) 在“Search Options”中根据需要勾选检索限定条件；

d) 用布尔逻辑运算符“AND”、“OR”或“NOT”连接所有检索词构建检索式，点击“Search”。

F4.2 检索结果导出

在检索结果界面，勾选目标题录，点击“Export”，导出时根据所选文献管理软件选择相应格式导出题录。

F.5 CINAHL(Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature)

F5.1 检索步骤

a) 进入EBSCOhost界面，选择CINAHL Complete数据库，系统默认“Basic”基本检索模式；

b) 在检索框输入检索词，根据需要在“Search Options”中选择检索限定条件；

c) 选择“Find any of my search terms”检索模式可在检索词之间自动添加“OR”，选择“Find all my search terms”可在检索词之间自动添加“AND”；

d) 构建好检索式，并确定限制和拓展条件后，点击“Search”进行检索。

F5.2 检索结果保存

点击检索结果界面右上角“文件夹”标志可保存结果至临时文件夹，如需长期保存结果，需注册EBSCOhost用户，导出时根据所选文献管理软件选择相应格式导出题录。

公示稿

附录 G
（资料性附录）
中文数据库检索步骤

G.1 至 G.4 给出了中国生物医学文献数据库、万方、中国知网、重庆维普数据库的检索步骤。

G.1 中国生物医学文献数据库(SinoMed)

a) 通过网址http://www.sinomed.ac.cn/进入SinoMed系统主页，点击页面右上角“请选择数据库”的下拉框中，选择“中国生物医学文献数据库”。

b) 可以在“高级检索”模块直接输入检索式进行检索，也可以直接在“快速检索”模块分步骤检索。

c) 该数据库将默认“快速检索”在“全字段”及“主题词”检索。

G.2 万方数据知识服务平台

a) 通过网址http://www.wanfangdata.com.cn/index.html进入万方数据知识服务平台主页；

b) 单击检索框旁的“高级检索”进入新网页后选择“专业检索”，根据需要选择文献类型，在检索框内按万方检索语法编辑检索式；

c) 平台限制每次检索框内输入的字符不超过800个。

G.3 中国知网数据库

a) 通过网址http://www.cnki.net/进入CNKI文献服务系统主页；

b) 点击检索框右侧的“高级搜索”；

c) 根据需要在“跨库”限定检索的子数据库范围，如学术期刊、博硕、会议、报纸、年鉴、专利、标准、成果等；

d) 检索途径建议使用“专业检索”功能；

e) 根据研究目的及检索框下方提示选择相应运算符，推荐运用“SU”主题字段检索；

f) 检索框限定最多仅能输入500个字，超出限制的检索式要进行拆分，干预措施检索式可拆分，但病名不建议拆分；

g) 拆分的检索式通过检索框右下方的“结果中检索”实现AND逻辑关系连接。

G.4 重庆维普数据库

a) 通过网址http://www.cqvip.com/进入CQVIP文献服务系统主页；

b) 进入“高级搜索”使用“直接输入检索式”模块；

c) 根据CQVIP检索表达式语法编辑病名、干预措施和研究类型的检索式（“*”代表“并且”，“+”代表“或者”，“-”代表“不包含”）；

d) 建议选择“题名或关键字”（即“M”）作为检索字段。该数据库检索式检索无字符限制。

公示稿

附录 H
（资料性附录）
Cochrane 偏倚风险评估工具

表H.1列出了文献方法学质量评价时Cochrane 偏倚风险评价工具的评价细节。

表 H.1 Cochrane 偏倚风险评估工具

条目	评价类别	判断依据
随机序列的产生	低风险	研究者描述的分组方法体现随机序列产生的方法，如使用“随机数字表”、SAS、excel 等软件、抽签等随机方法
	高风险	研究者描述的分组方法为非随机的，如按就诊顺序、住院号、门诊号、就诊日期、患者意愿、医生判断等进行分组
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断，如正文中只提及“随机”、“分层随机”或“区组随机”，没有随机数字产生的具体描述
分配隐藏	低风险	研究者和受试者无法预先知晓分组的情况，如通过电话、网络、药房等进行中央随机、采用按顺序编号密封、不透光的信封等分组
	高风险	通过以下方法分组，研究者或受试者可预先知晓分组的情况：如公开未独立保存的随机数、使用非密封或可透光的随机序号信封、按就诊顺序交替入组、按住院号、门诊号、就诊日期、受试者生日等进行分组
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断
研究者盲法	低风险	以下任意一种情况： ● 使用安慰剂等方法对研究人员设盲，盲法不太可能被破盲； ● 系统评价作者认为在缺乏盲法（没有设盲或盲法不完整）的情况下，结局指标并不太可能受其影响
	高风险	以下任意一种情况： ● 没有设盲，且结局指标很可能受其影响 ● 虽然对研究者设盲了，但是设盲的方法可能会被研究人员破盲，且结局指标很可能受其影响
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断
受试者盲法	低风险	以下任意一种情况： ● 使用安慰剂等方法对受试者设盲； ● 系统评价作者认为在缺乏盲法（没有设盲或盲法不完整）的情况下，结局指标并不太可能受其影响
	高风险	以下任意一种情况： ● 没有设盲，且结局指标很可能受其影响 ● 虽然对受试者设盲了，但是设盲的方法可能会被受试者破盲，且结局指标很可能受其影响
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断
结局评价者盲法	低风险	以下任意一种情况： ● 系统评价作者认为在缺乏盲法（没有设盲或盲法不完整）的情况下，结局指标的测量并不太可能受其影响 ● 对结局评价者设盲，且过程不可能被破盲
	高风险	以下任意一种情况： ● 没有设盲，且结局指标的测量很可能受其影响 ● 虽然对结局评价者设盲了，但在实施过程中，很可能被破盲，且结局指标的测量很可能受其影响
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断

公示稿

表 H.1 Cochrane 偏倚风险评估工具（续）

条目	评价类别	判断依据
结局数据的完整性	低风险	以下任意一种情况： ● 没有数据缺失 ● 数据缺失的原因不影响到真实结局，如生存数据，删失不太可能导致偏倚 ● 组间缺失数据的数量均衡、缺失原因相似 ● 分类变量结局，缺失数据的比例相比于观测事件率，对干预效应的评估不足以导致临床相关影响 ● 连续变量结局，缺失数据中似真效应（均数差或标准均数差）对观测效应大小不足以产生临床相关的影响 ● 使用了恰当的数据填补方法填补缺失数据
	高风险	以下任意一种情况： ● 数据缺失的原因可能与真实结局相关 ● 缺失数据的数量和原因在组间不平衡 ● 分类变量结局，缺失数据的比例相比于观测事件率，对干预效应的评估上会导致临床相关影响 ● 连续变量结局，缺失数据中似真效应（均数差或标准均数差）对观测效应大小评估会产生临床相关的影响 ● 当实施过程中有大量违反随机分配的干预方案，却采用了“按实际干预分析” ● 潜在可能不恰当的简单数据填补
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断
结果选择性报道	低风险	以下任意一种情况： ● 可获得研究方案，文章报告了研究方案中预先确定的结局指标 ● 研究方法无法获得，但已发表的文章中清晰地涵盖了全部期待的结局
	高风险	以下任意一种情况： ● 研究方案（protocol）中预先确定的结局指标并没有全部报告 ● 一个或多个主要结局指标不是按预先确定的方式报告（测量方法、分析方法、亚组） ● 系统评价感兴趣的一个或多个指标没有全部报告，以至于无法纳入 meta 分析 ● 某结局指标在一类研究中期望很高，但是这个文章没有报告
	不清楚	以下任意一种情况： ● 研究者报告的信息不足以判断 ● 文章没有提到此结局
其它	低风险	研究没有其他偏倚风险
	高风险	至少有一个重要的偏倚风险，如：有潜在的与特定设计相关的偏倚来源
	不清楚	研究者报告的信息不足以判断

公示稿

附录 I
（资料性附录）
PICO 评价示例

表I.1和表I.2列出了临床PICO问题重要性评价的示例。

表I.1为临床PICO问题重要性评价所需记录内容的示例。

表 I.1 PICO 评价示例

受试者（研究人群特征）				
如，气阴两虚证的 2 型糖尿病患者				备注
如，COPD 稳定期患者				
干预				
	干预措施	重要性(1-9 分)	赋分理由	备注
针灸	针刺			
	穴位敷贴			
	穴位注射			
	耳针			
中药	中药			
	补中益气汤			
	玉屏风散			
其他疗法	太极			
	按摩			
对照				
		重要性(1-9 分)	赋分理由	备注
中医干预 *vs.* 安慰剂				
中医干预 *vs.* 西药疗法				
中医干预+西医疗法 *vs.* 西医疗法				
结局				
		重要性(1-9 分)	赋分理由	是否纳入 SOF？
结局指标 1				是　否
结局指标 2				是　否
结局指标 3				是　否
结局指标 4				是　否
结局指标 5				是　否
结局指标 6				是　否
结局指标 7				是　否
结局指标 8				是　否
结局指标 9				是　否
注：证据总结表中必须有一项是不良事件。				

表I.2为临床PICO问题重要性评价中，各项目重要性评级的分级及相应的意义。

表 I.2 评级表

1	2	3	4	5	6	7	8	9
↑最不重要								↑最重要
该项不重要			该项重要非关键			该项重要关键		

公示稿

附录 J
（资料性附录）
证据总结表范例

表J.1列举了中药方小青龙汤联合药物疗法与药物疗法对比治疗急性加重慢性阻塞性肺疾病的证据。

表 J.1 小青龙汤+药物疗法与药物疗法对照治疗急性加重期慢性阻塞性肺疾病研究结果

结局指标	研究数量	证据质量（GRADE）	相对效应（95%CI）	预期绝对效应	
				药物疗法风险	药物疗法+小青龙汤风险差
肺功能:FEV1%预测值 随访：平均 12.75 天（治疗结束后）	337 （4RCTs）	⊕⊕○○ 低[ab]	-	对照组平均肺功能 51.59%	MD 较药物疗法升高（5.29-9.23）
生活质量:SGRQ[d] 随访：平均 7（治疗结束后）	80 （1RCT）	⊕⊕○○ 低[ab]	-	对照组平均生活质量 64.6 单位	MD 较药物疗法降低 7.9（12.07-3.73）
呼吸困难：mMRC 量表[e] 随访：平均 7 天（治疗结束后）	80 （1RCT）	⊕⊕○○ 低[ab]	-	对照组平均呼吸困难 2.05 单位	MD 较药物疗法降低 0.25（0.5-0）
动脉血气分析:PaO2 随访：平均 13.33 天（治疗结束后）	504 （6RCTs）	⊕⊕○○ 低[ab]	-	对照组平均动脉血气分析 75.48mmHg	MD 较药物疗法升高 4.83（3.76-5.91）
动脉血气分析:PaCO2 随访：平均 13 天（治疗结束后）	456 （5RCTs）	⊕⊕○○ 低[ab]	-	对照组平均动脉血气分析 55.09mmHg	MD 较药物疗法降低 5.65（6.38t-4.93）
不良事件	没有研究报道了不良事件				

注 1：CI 即置信区间，治疗组的危险度（95%CI）基于对照组假定的危险度以及治疗组相对效应（95%CI）。

注 2：GRADE 工作组证据分级

- 高，我们非常确信真实的效应值接近效应估计值；
- 中，对效应估计值我们有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大不相同的可能性；
- 低，我们对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同；
- 极，低我们对效应估计值几乎没有信心：真实值很可能与估计值大不相同。

[a] 受试者和研究人员未设置双盲。
[b] 数据异质性大。
[c] 样本量不足限制了结果的准确性。
[d] SGRQ 量表:0-100 分.SGRQ 得分低表示改善了生活质量。
[e] mMRC 量表：0-4 单位.mMRC 得分低表示改善了呼吸困难。

公示稿

附录 K
（资料性附录）
证据总结表相关定义和规范表达

表K.1描述了证据总结表的相关定义和规范表达。

表 K.1 证据总结表相关定义和规范表达

质量等级	定义	显著差异	较小差异	差异不明显或无差异
高质量	我们非常确信真实的效应值接近效应估计值	改善	稍改善一点	无改善
中等质量	对效应估计值我们有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大不相同的可能性	很可能改善	很可能稍改善	很可能无改善
低质量	我们对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同	可能改善	可能稍改善	可能无改善
极低质量	我们对效应估计值几乎没有信心：真实值很可能与估计值大不相同	不确定该干预措施是否可以改善该结局指标，因为证据质量极低		
无数据或研究	未报道相关结局指标，未发现相关干预措施对该干预指标作用的文章			

公示稿

参考文献

[1]Wells GA, Shea B, O’ Connell D, et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses [EM/OL]. [2020-03-26]. http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp

[2] Downs SH, Black N. The Feasibility of Creating a Checklist for the Assessment of the Methodological Quality Both of Randomised and Non-Randomised Studies of Health Care Interventions[J]. Journal of

Epidemiology and Community Health,1998,52(6):377-84.

[3]Sterne JA, Hernan MA, Reeves BC, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions[J]. BMJ, 2016,355:i4949

[4]孙凤,高乐,杨智荣,等.偏倚风险评估系列：(五)非随机干预性研究[J].中华流行病学杂志,2018,39(3):374-381.

[5]张天嵩,钟文昭,李博.实用循证医学方法学[M].第 2 版.长沙:中南大学出版社,2014.

公示稿